STOA

# PIEDS OPTIMAUX

PROTOCOLE PRATIQUE



## TOUS LES JOURS - 10 MIN

- Étirement des orteils
- Mollet et soléaire
- Levées et écartement des orteils
- Pied court

## 3 FOIS PAR SEMAINE

- Serviette et élévations du talon
- Cheville en quatre directions
- Coquille et équilibre sur un pied

**Mouvement lent. Aucune douleur vive. Pas d'aggravation le lendemain.**

STOA

# Libérer les tissus



## 01 ÉTIREMENT DES ORTEILS

**2 x 30 s / pied - tous les jours**

1. Assis, posez la cheville sur le genou opposé.
2. Ramenez les orteils vers le tibia, surtout le gros orteil.
3. Sentez la tension sous la voûte sans provoquer de douleur vive.





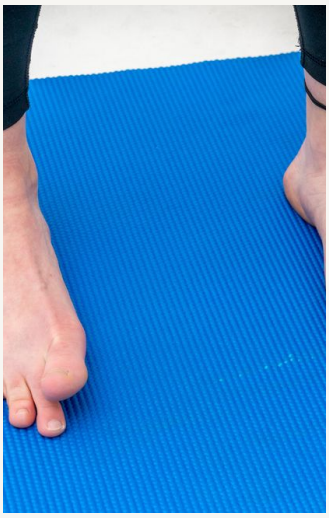
## 02 MOLLET ET SOLÉAIRE

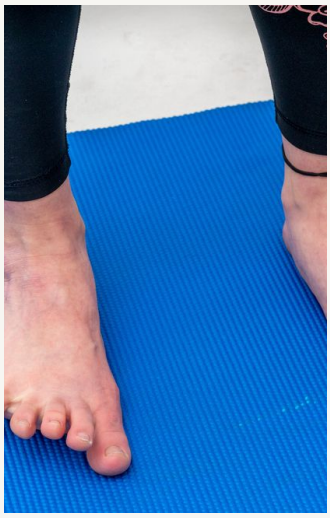
**2 x 30 s / position**

1. Face au mur, reculez une jambe et gardez le talon au sol.
2. Genou arrière tendu : étirez le mollet.
3. Genou arrière fléchi : étirez le soléaire.

STOA

# Réveiller les orteils





## 03 LEVÉES D'ORTEILS

**2 x 10 / variante**

1. Gardez talon et avant-pied au sol.
2. Levez le gros orteil en laissant les quatre autres au sol.
3. Inversez : gros orteil au sol, quatre autres levés.



## 04 ÉCARTEMENT ACTIF

**2 x 10 - maintien 5 s**

1. Posez les orteils à plat, sans les recroqueviller.
2. Écartez-les en éventail ; éloignez le gros orteil du deuxième.
3. Aidez le mouvement avec les doigts si nécessaire.



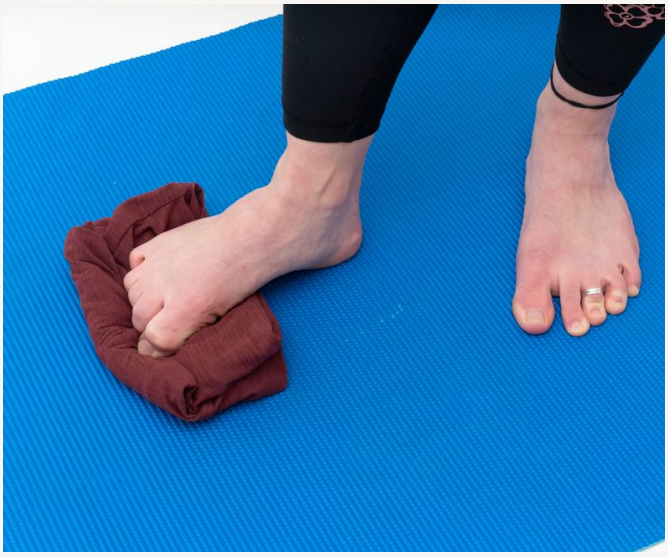

## 05 PIED COURT

**3 x 20 s / pied**

1. Gardez au sol le talon et la base du premier et du cinquième orteil.
2. Rapprochez l'avant-pied du talon sans plier les orteils.
3. La voûte se soulève ; relâchez lentement.

STOA

# Renforcer le pied



## 06 FROISSEMENT DE SERVIETTE

**2 x 45 s / pied - 3 fois / semaine**

1. Posez une serviette à plat et gardez le talon stable.
2. Ramenez-la vers vous avec les orteils.
3. Relâchez complètement entre chaque prise ; arrêtez si une crampe apparaît.





## 07 ÉLÉVATION DU TALON

**3 x 8 à 15 - 3 fois / semaine**

1. Gardez la base du gros et du petit orteil en contact.
2. Montez lentement sans basculer sur le bord externe.
3. Progressez : deux jambes, une jambe, puis sur une marche.



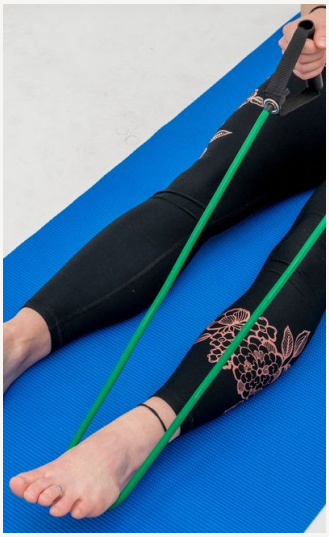

## 08 AUTO-MASSAGE À LA BALLE

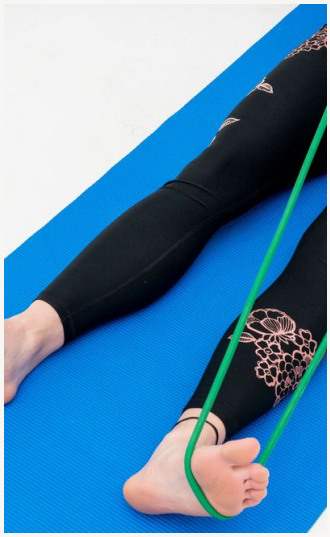
**60 à 90 s / pied - pression modérée**

1. Placez une balle souple sous la voûte.
2. Roulez lentement du talon vers l'avant-pied.
3. Évitez toute zone douloureuse, engourdie ou inflammatoire.

STOA

# Stabiliser la chaîne

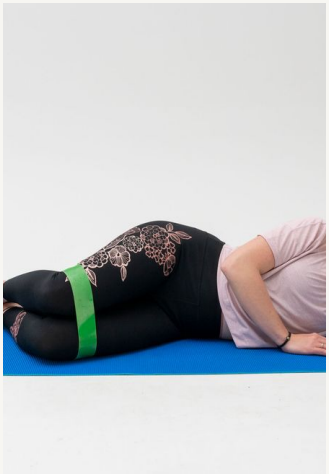


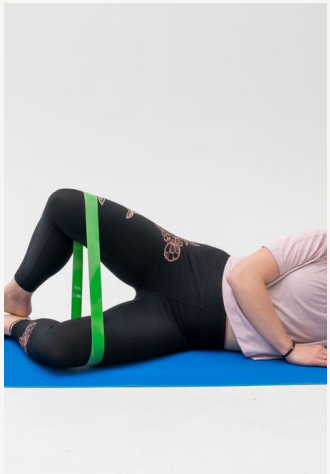


## 09 CHEVILLE : 4 DIRECTIONS

**2 x 12 / direction - 3 fois / semaine**

1. Placez l'élastique autour de l'avant-pied.
2. Tirez vers vous, poussez, tournez dedans puis dehors.
3. Gardez le genou immobile et contrôlez le retour.





## 10 COQUILLE

**2 x 12 à 15 / côté**

1. Allongez-vous sur le côté, genoux fléchis, pieds joints.
2. Ouvrez le genou du dessus sans rouler le bassin en arrière.
3. Progressez avec un élastique léger au-dessus des genoux.



## 11 ÉQUILIBRE TRIPODE

**3 x 30 à 45 s / pied**

1. Ancrez talon, base du gros orteil et base du petit orteil.
2. Tenez sur une jambe sans agripper le sol avec les orteils.
3. Progressez avec de petits squats ou un support légèrement instable.

STOA

# Séparateurs d'orteils



## SILICONE MÉDICAL

1. Choisissez un séparateur interdigital de taille adaptée, idéalement conseillé et ajusté par un podologue.
2. Commencez 10 à 15 minutes au repos.
3. Ajoutez 5 à 10 minutes tous les 3 à 4 jours si la peau et la sensibilité restent normales.
4. Ne dormez pas avec et ne l'utilisez pas pendant le sport sauf indication professionnelle.
5. Retirez-le si douleur, engourdissement, frottement ou changement de couleur.

# Progression sur 8 semaines

**1-2** **MOBILITÉ ET CONTRÔLE**

Routine quotidienne. Renforcement 2 fois par semaine. Séparateurs 10 à 20 min.

**3-4** **VOÛTE ET APPUI**

Renforcement 3 fois par semaine. Pied court debout. Équilibre sur une jambe.

**5-6** **FORCE**

Élévations sur une jambe. Élastique plus ferme. Séparateurs jusqu'à 45 à 60 min si tolérés.

**7-8** **INTÉGRATION**

Marche lente avec appui tripode. Maintenez la routine qui améliore réellement vos symptômes.

**ARRÊT ET AVIS PROFESSIONNEL**

Douleur vive, gonflement, perte de sensibilité, changement de couleur, lésion cutanée ou aggravation durable. Diabète, neuropathie ou trouble circulatoire : utilisez les séparateurs uniquement après validation clinique.